Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5024485-56.2024.8.21.0008/RS

AUTOR: FLAVIA OLSSON MOREL
RÉU: MUNICÍPIO DE CANOAS / RS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

FLAVIA OLSSON MOREL ajuizou ação ordinária em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE CANOAS/RS**, alegando possuir diagnóstico de **Neoplasia Hematológica Mielofibrose Aguda (CID10-C94.5)**. Refere que, em razão de sua enfermidade, necessita fazer uso do medicamento **Ruxolitinib**. Requereu, em sede antecipatória do mérito, o fornecimento do medicamento pelos réus (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela de urgência (evento 18, DESPADEC1).

A parte autora interpôs agravo de instrumento que foi julgado procedente, determinando aos demandados que forneçam a medicação pleiteada (processo 5221745-20.2024.8.21.7000/TJRS, evento 23, RELVOTO1).

Citados, os demandados contestaram. O Estado do Rio Grande do Sul sustentou que, conforme o Tema 793 do STF, o pedido de tratamento oncológico gera necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, ainda, que ausente comprovação dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF (evento 25, CONT1).

O Município de Canoas alegou, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo com a União e de ilegitimidade passiva do Município, conforme Temas 793 e 1234 do STF. No mérito, requereu a improcedência da ação devido a não incorporação do fármaco pelo Ministério da Saúde, a existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS (evento 46, CONT1).

Efetuado o bloqueio de valores para assegurar 3 meses de tratamento com o fármaco (evento 63, DESPADEC1), a parte autora apresentou prestações de contas (evento 90).

Intimada a parte autora para comprovar os requisitos estabelecidos pelas teses fixadas nos Temas 6 e 1234, do STF (evento 147, DESPADEC1).

O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município e, no mérito, pela improcedência do pedido (evento 176, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Decido.

DAS PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva do Município de Canoas

O Município de Canoas suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que os acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral) estabeleceram uma nova sistemática de repartição de responsabilidades financeiras, excluindo-o do dever de custear tratamentos não incorporados cujo valor anual supere o patamar de sete salários-mínimos.

A preliminar merece acolhimento.

É cediço que o Sistema Único de Saúde (SUS) se alicerça sobre o princípio da responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme se extrai da interpretação conjunta dos artigos 23, II, e 196 a 198 da Constituição Federal. Tal solidariedade, por muito tempo, foi interpretada de forma a permitir que o cidadão demandasse contra qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, para a obtenção de prestações de saúde.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a complexa e multifacetada questão da judicialização da saúde, buscou, por meio de uma governança judicial colaborativa, estabelecer parâmetros mais claros e racionais para a distribuição de competências e responsabilidades, visando a garantir não apenas o direito individual do paciente, mas também a sustentabilidade e a organização do sistema público de saúde como um todo. Nesse contexto, o julgamento do Tema 1234 representou um marco fundamental, ao homologar acordos celebrados entre os próprios entes federativos, que definiram fluxos e critérios para o custeio de medicamentos não incorporados.

Ainda, considerando que o **medicamento** postulado não integra a lista do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, o município não tem a obrigação de fornecê-lo, conforme o artigo 2º da Resolução nº 459/17 - CIB/RS.

Dessa forma, diante da ausência de interesse de agir, em face do ente municipal, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva *ad causam*.

Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da competência

A questão da competência está superada pela tese fixada no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral - Tema 1234, publicado em 19/09/2024. Segue o trecho do voto relativo à competência, com redação alterada após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina:

> *I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.*

No ponto, houve a modulação de efeitos para aplicação aos processos ajuizados após a publicação do julgamento no DJE, que ocorreu em 19/09/2024:

> *Por fim, modulo os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

Ainda sobre a competência, o Ministro Relator, no voto vencedor, que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela União, definiu:

> *3) acolho parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.*

No caso, o ajuizamento do processo ocorreu em 17/07/2024, assim, tendo em vista que modulados os efeitos do aludido *decisum* em relação à competência do órgão jurisdicional, passando a ser caso de declinação, quando cabível e conforme o Acórdão, somente nos processos ajuizados após 19/9/2024.

Assim, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual.

<u>DO MÉRITO</u>

Direito à Saúde

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu artigo 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde -, e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e do Município, a ser ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. Nesse sentido a Apelação Cível nº 70050003987, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/07/2012.

Do tratamento postulado

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tratou dos requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, por meio dos Temas n°s 1234 e 6, que geraram as respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, abaixo reproduzidas:

> *Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*

> *Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Através da edição o Tema nº 06, o STF fixou a tese de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

> *(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;*
>
> *(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*
>
> *(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;*
>
> *(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;*
>
> *(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e*
>
> *(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.*

Ainda, conforme a tese firmada no Tema 1234 do STF, estabeleceu-se que:

> *IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de* ***medicamento*** *pelo SUS. 4)* ***Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.*** *4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (Grifou-se)*

É importante ressaltar que, com início em julho de 2024, o processo foi devidamente saneado após os relevantes Temas referentes ao fornecimento de medicamentos, bem como os documentos foram requeridos alinhados a essas deliberações.

Segundo laudo médico acostado ao feito (evento 156, LAUDO2), a parte autora é portadora de **Neoplasia Hematológica Mielofibrose Aguda (CID10-C94.5) risco DIPSS plus 4 (risco alto)**, necessitando do uso do medicamento postulado, buscando melhora da qualidade de vida.

Entretanto, inobstante a prescrição do profissional que atende a parte, verifica-se que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, avaliou o pedido de incorporação do medicamento postulado, não sendo recomendado seu uso para a patologia da parte autora, decidindo, dessa forma, pela não incorporação no SUS, conforme dispõe a PORTARIA SCTIE/MS Nº 54, DE 1º DE JULHO DE 2022:

Tecnologia Avaliada	Indicação	Relatório Técnico	Relatório para a Sociedade	Recomendação da Conitec Final	Decisão do Ministério da Saúde	Portarias	Data da Publicação
Ruxolitinibe	Tratamento de pacientes com mielofibrose primária, mielofibrose pós policitemia vera ou mielofibrose pós trombocitemia essencial, de risco intermediário-2 ou alto	Nº 531	Nº 193	Não incorporar	Não incorporar	SCTIE/MS nº 20/2020	16/06/20
Ruxolitinibe	Tratamento de pacientes com mielofibrose, risco intermediário-2 ou alto, com plaquetas acima de 100.000/mm3, inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoéticas	Nº 735	Nº 334	Não incorporar	Não incorporar	SCTIE/MS nº 54/2022	04/07/22

PORTARIA SCTIE/MS Nº 54, DE 1º DE JULHO DE 2022

Decisão de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o ruxolitinibe para tratamento de pacientes com mielofibrose, risco intermediário-2 ou alto, com plaquetas acima de 100.000/mm3, inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoéticas.

Ref.: 25000.176818/2021-66, 0027822722.

A SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o ruxolitinibe para tratamento de pacientes com mielofibrose, risco intermediário-2 ou alto, com plaquetas acima de 100.000/mm3, inelegíveis ao transplante de células-tronco hematopoéticas.

Art. 2º A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art. 3º O relatório de recomendação da Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SANDRA DE CASTRO BARROS

Desse modo, não estando comprovado pela demandante todos os requisitos fixados pelos Temas 1234 e 6 do STF, especialmente que o ato administrativo de indeferimento/não incorporação não está conforme as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), a pretensão não merece acolhimento.

No mesmo sentido desta sentença é o parecer ministerial (evento 176, PROMOÇÃO1).

Por fim, não se pode ignorar que o STF deu ênfase que ficará sujeita a nulidade a decisão judicial que condenar o ente público à dispensação de fármaco sem a estrita observância dos requisitos estipulados nas teses mencionadas, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE INFANTIL ASSOCIADO A OUTRAS COMORBIDADES. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE SEMAGLUTIDA. ***MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 1234 E 06 PELO STF. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.*** *I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto pela parte autora da ação originária, adolescente diagnosticado com obesidade e outras comorbidades, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 1234 e 06 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que pleiteado o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Entretanto, ao julgar o mérito dos Temas 1234 e 06, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros para o fornecimento judicial de medicamentos que não estejam incorporados às políticas públicas do SUS. Nesse passo, sob pena de nulidade da decisão judicial, deve analisado o preenchimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. In casu, o autor, menor, foi diagnosticado com Obesidade Grave e Dislipidemia, além de Transtorno do Espectro Autista, necessitando, conforme prescrição médica, do fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy), o qual não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja atualização é de responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), conforme estabelecido pelo o Decreto n. 7.646/2011. Além disso, não há notícias de que tenha havido avaliação pela CONITEC com recomendação pela incorporação ou não do medicamento ao SUS. Cuida-se, portanto, de medicamento não incorporado, conforme o item 2.1 do julgamento meritório do Tema n. 1234. Nesse passo, em atenção às teses fixadas pelo STF, denota-se que, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, a parte autora ignora a necessidade de atendimento às teses firmadas nos Temas 1234 e 06, limitando-se a sustentar que o laudo médico juntado aos autos seria suficiente para alicerçar a pretensão. Quer dizer, a parte autora não apontou absolutamente nada sobre os temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal, omitindo-se da comprovação individualizada dos requisitos do Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, ônus que lhe competia, pois o ajuizamento da ação ocorreu posteriormente à ata de publicação do tema. Nesse contexto, por mais esforço que seja feito em prol da parte autora, à luz de todos os elementos contidos nos autos, especialmente levando em conta o laudo médico, tem-se que não há apontamento a respeito da "[...] ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação [...]", bem como não há apontamento a respeito da "[...] comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco [...]". Os apontamentos do laudo no sentido de que o enfermo fez uso de outras medicações previamente e de que não haveria medicação com melhor efeito para o seu quadro clínico, evidentemente, não servem como base científica para a prescrição da Semaglutida para o tratamento de obesidade infantil. Ademais, ao receber o presente recurso e indeferir a liminar recursal, oportunizou-se ao autor que trouxesse novo laudo médico melhor fundamentado, em atenção expressa às diretrizes dos Temas 1234 e 06, o que não ocorreu. Aliado a isso, ainda não fora realizada nota técnica pelo NatJus, o que também se faz necessário para servir de alicerce à decisão quanto à concessão ou não do pedido liminar, na esteira do que decidido pela Corte Suprema. Dessarte, diante do que se tem até o presente momento, imperiosa a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO. Recurso desprovido, à unanimidade. V. JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS. STF, Temas 1234 e 06; artigo 196 da Constituição Federal.(Agravo de Instrumento, Nº 50996132420258217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 22-08-2025)*

Dessa forma, em que pese as alegações médicas e a comprovada incapacidade financeira, entendo que não restou comprovado o direito alegado, sendo caso de improcedência.

Ante o exposto:

a) **RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA** do **MUNICÍPIO DE CANOAS** para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual julgo **extinto** o feito em relação a este, sem resolução de mérito, fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC;

b) resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido ajuizado por **FLÁVIA OLSSON MOREL** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

HOMOLOGO, no aspecto formal, as contas prestadas nos autos (evento 90), observando-se que a decisão do bloqueio de valores foi realizada anteriormente ao julgamento do Tema 1234 do STF. Assim, o valor do PMVG e os critérios estabelecidos não retroagem a este caso.

Pela sucumbência, condeno a parte autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, que arbitro em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida no evento 18, DESPADEC1 (art. 98, § 3º do CPC).

Caso interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Agendada a intimação eletrônica das partes.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 27/10/2025, às 15:11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093969319v13** e o código CRC **4bc8fd84**.